جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : فاطمه حسن احمد حسن

المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** عين شمس **العنوان :** شارع جسر السويس - فندق السلام

رقم البطاقة : 26512250105141 **رقم التليفون :** 01002371670 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 15-10-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 25-12-1965 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي
التوقيع:(----------)

المقر بما فيه
التوقيع:(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام ماموجرام وسونار علي الثديين [10888] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: فاطمه حسن احمد حسن
National ID: 26512250105141

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Bilateral mammogram and breast ultrasound**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





National ID - Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Patient Name	: الاستاذه / فاطمه حسن احمد حسن		
Patient No.	: 26512250105141	Request No.	: 13003725
Path No.	: SR-1430/24	Request Date	: 26/09/2024
Sex	: Female	Verification Date	: 08/10/2024
Age	: 58 Y	Financial Category	: اورام دار السلام - نقابة الدولة
Referreing Doc	:	Department	: Out Patient
		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Right breast cancer.
Nature of Specimen: Slide Revision

Gross Examination:
- 1 paraffin block labeled by (5445/24) and 3 slides were received.

Microscopic Examination:
* Histological type: Invasive duct carcinoma.
* Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): Grade II (3+2+1)
* DCIS: No.
* Angioinvasion: No.
* Perineural invasion: No.
* IPT:
- ER: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (score 8 /8).
- PR: Moderate nuclear reaction in 60% of tumor cells(score 6 /8).
- Her2: No membrane reaction in the tumor cells (score 0).

Diagnosis:
Right breast cancer, Slide revision:
Invasive duct carcinoma GII.
IPT:
- ER: Positive (score 8 /8).
- PR: Positive (score 6 /8).
- Her2: Negative (score 0).

Signature
Dr. Marwa Mahmoud.
Dr. Menna Nabil.

Verified by :
DR.Menna Nabil

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة .. القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Name: فاطمة حسن احمد حسن **MR. :** 2939	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالتها

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انها

The pathology review performed in October 2024 confirmed invasive ductal carcinoma, grade II. Immunohistochemistry demonstrated strong positivity for GATA3, estrogen receptor positivity with a score of 8/8, progesterone receptor positivity with a score of 6/8, HER2 negativity (score 0), and a Ki-67 proliferation index of 20 % of tumor cells. Multidisciplinary discussion in February 2025 recommended a treatment plan consisting of one port-a-cath placement, initiation of zoledronic acid (Zometa) for six months, and commencement of letrozole (Femara) with supportive care for three months, with the next follow-up scheduled for 18 October 2026. The patient is to continue the prescribed regimen as outlined.

تحريرا في ,

التاريخ :	**20-09-2026**	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : نهي سعيد علي محمد

يعتمد ,

Patient Name	الاستاذه / فاطمه حسن احمد حسن		
Patient No.	26512250105141	Request No.	13003725
Path No.	SR-1430/24	Request Date	26/09/2024
Sex	Female	Verification Date	21/10/2024
Age	58 Y	Financial Category	اورام ثلاثة السلام - نفقة الدولة
Referreing Doc.		Department	Out Patient
		Registered by	.marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

* Scoring system: "ER, PR"
ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.
* Scoring system: "Her2"
Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations, 2013.IHC 0: as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within < 10%of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is incomplete, intense < 10% of tumor cells.

Signature
Dr. Marwa Mahmoud.
Dr. Toka Medhat.

Verified by :
Dr.Toka Medhat

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

Patient Name	الأستاذه / فاطمه حسن احمد حسن	Request No.	13003725
Patient No.	26512250105141	Request Date	26/09/2024
Path No.	SR-1430/24	Verification Date	21/10/2024
Sex	Female	Financial Category	اورام دار السلام - نقدة الدولة
Age	58 Y	Department	Out Patient
Referreing Doc.		Registered by	.marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

* Scoring system: "ER, PR"
ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.
* Scoring system: "Her2"
Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations, 2013.IHC 0: as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within < 10%of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is incomplete, intense < 10% of tumor cells.

Signature
Dr. Marwa Mahmoud.
Dr. Toka Medhat.

Verified by :
Dr.Toka Medhat

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
ادارة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Fatma Hassan Ahmed Hassan	Date : 16/09/2024
Exam : C.T ABDOMEN &PELVIS	Age : 58 Year(s)
Medical ID: 3152/2024	Pat. ID: 79117

NON CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -

1. **Chest:**
   - Right breast UIQ ill defined soft tissue lesion associated with surrounding parenchymal distortion measuring about 30x 18 mm.
   - Few small right axillary lymph nodes (level 1), for US correlation.
   - Few tiny subpleural pulmonary nodules, the largest is seen at right lower lung lobe measuring about 6 mm.
   - No pulmonary masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
   - No hilar or mediastinal lymph nodes.
   - No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
   - Normal cardiac size. No pericardial effusion detected.
   - Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
   - Normal appearance of the dorsal vertebrae.
2. **Abdomen and pelvis:**
   - The liver is average in size with homogenous CT texture. No focal lesions (on non contrast basis)or contour irregularities.
   - No intra-hepatic or extra-hepatic billary radicles dilatation.
   - Multiple small portocaval, peripancreatic and porta- hepatis as well as bilateral external iliac lymph nodes, the largest measuring about 0.7x 1.2 cm, likely inflammatory for follow up.
   - Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
   - Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
   - Normal non contrast appearance of the pancreas and both suprarenals.
   - Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
   - Normal appearance of the other pelvic organs.
   - No abdominal or pelvic collections.
   - Few dorsolumbar tiny lucent lesions.

OPINION:

- ***Right breast UIQ malignant mass lesion.***
- ***Few subcentimetric bilateral pulmonary nodules, for follow up.***
- ***No definite hepatic metastatic deposits on non contrast basis.***

Dr. Ghada H. Khalifa, MSc

Dr. mohamed Mohsen, M.D.

Dr. mohamed Mohsen, M.D.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]